

Radiografía Clínica de la Conducta Suicida

De la vigilancia epidemiológica a la intervención integral en Colombia.

Síntesis basada en datos del INS (Ficha 356), Medicina Legal (Feb 2025) y evidencia académica (Tejidos Sociales).

EL ESTADO CRÍTICO: ENERO - FEBRERO 2025

414

muertes por suicidio registradas en solo 59 días en Colombia.

RAZÓN DE SEXO:



Los hombres emplean métodos de mayor letalidad, mientras las mujeres presentan mayores tasas de intento.

ZONAS DE MAYOR CARGA:



LA CARGA OCULTA: EL MODELO DEL ICEBERG

414 MUERTES

(Casos consumados, Feb 2025)

La OMS establece una proporción de 20:1 entre intentos y suicidios consumados a nivel global.

~8,280 INTENTOS ESTIMADOS

(La verdadera carga del sistema de salud en el mismo periodo)

El intento de suicidio es la variable predictiva más fuerte. Prevenir la reincidencia es salvar una vida.

Zonas de Riesgo por Etapa de Vida

Adolescencia (12 a 17 años): 35 casos.

Juventud (18 a 28 años): 114 casos.

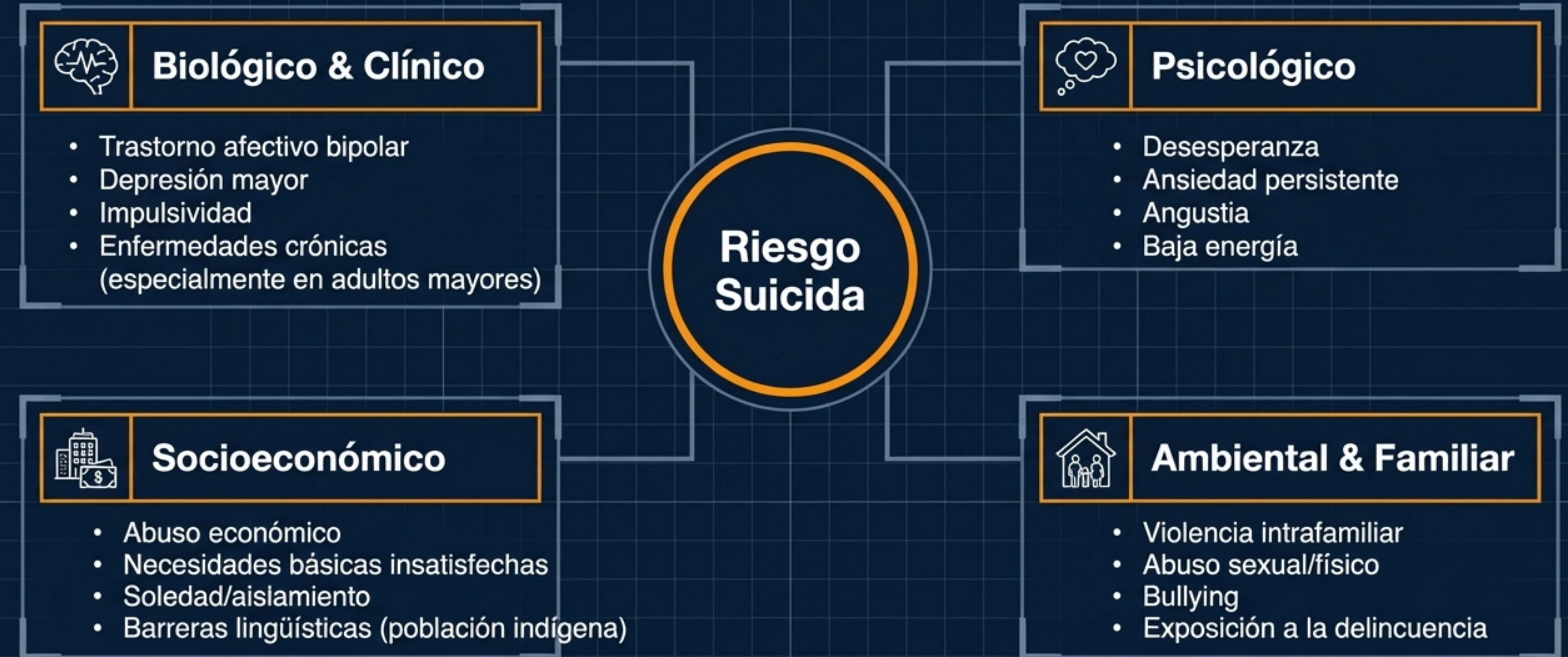
Adulthood temprana (29 a 44 años): 107 casos.

Adulthood intermedia (45 a 59 años): 79 casos.

Anciano joven (60 a 74 años): 54 casos.

El 53% de las muertes se concentran en jóvenes y adultos jóvenes (18-44 años).
Es una crisis de la población en edad productiva.

Anatomía del Riesgo: Un Fenómeno Multifactorial



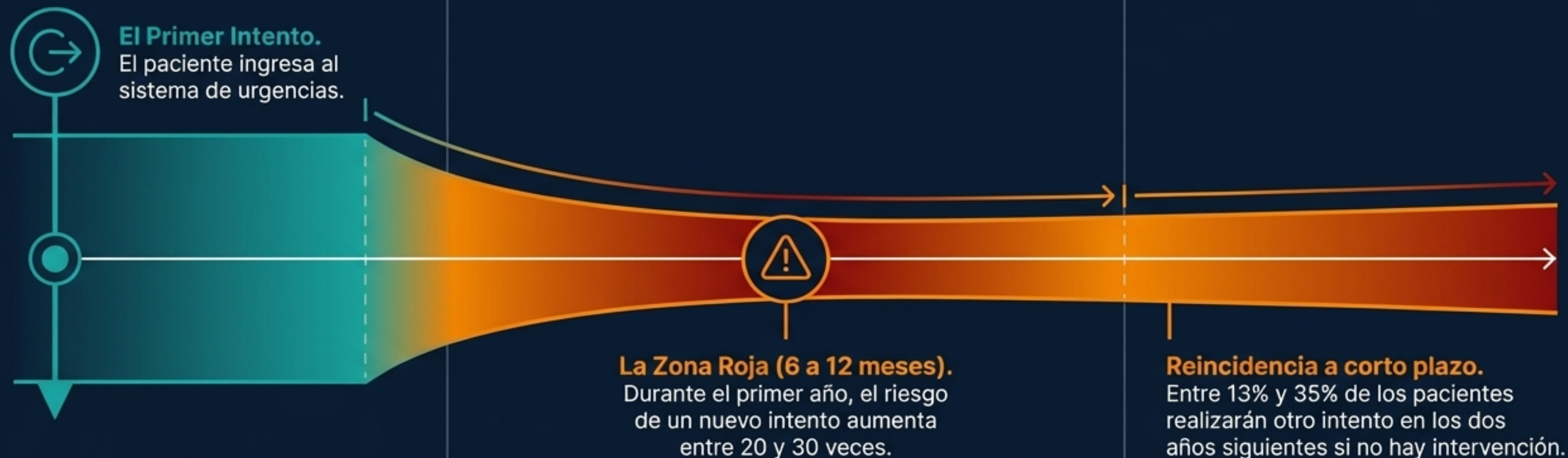
Perfiles Clínicos por Ciclo Vital

Adolescentes y Jóvenes		Adultos y Personas Mayores	
• Bullying, bajo rendimiento académico, disfunción familiar, violencia en el hogar.	Desencadenantes Principales	• Soledad, ausencia de ingresos, enfermedades físicas, maltrato económico.	
• Alta impulsividad, efecto imitación (redes/medios).	Modificadores de Riesgo	• Falta de pareja estable, aislamiento progresivo.	
• Cannabis, alcohol (falla en regulación emocional).	Consumo de Sustancias (SPA)	• Alcoholismo crónico, alucinógenos, nicotina.	

“El intento previo es el predictor más fuerte de riesgo suicida.”

El 40% de las personas que intentan suicidarse han tenido intentos previos.
Las personas con riesgo realizan manifestaciones prodrómicas medibles.
No es un evento súbito; es un proceso.

La Ventana Crítica de Intervención



**El alta médica por la lesión física no es el fin del tratamiento;
es el inicio de la vigilancia epidemiológica.**

Escala SAD PERSONS: Valoración del Riesgo

(1 punto por cada una)

- ☐ Sexo: Varón (+1)
- ☐ Age (Edad): <19 o >45 años (+1)
- ☐ Depresión (+1)
- ☒ Previous attempt (Intentos previos) (+1)
- ☐ Exceso de alcohol/sustancias (+1)
- ☐ Racionalidad perdida (Trastornos cognitivos) (+1)
- ☐ Sin apoyo social (+1)
- ☐ Organized plan (Plan organizado) (+1)
- ☐ No pareja estable (+1)
- ☐ Sickness (Enfermedad somática) (+1)



Protocolo de Triage y Derivación



Ficha 356: El Interruptor del Sistema

No es burocracia, es la alerta temprana.



La notificación semanal de los casos confirmados al SIVIGILA no es un fin estadístico. Es el **mecanismo legal y clínico** que activa la obligación de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para garantizar la prestación de servicios y seguimiento.

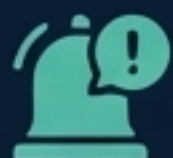
NUNCA se notifican las ideaciones, únicamente los intentos confirmados.

La Arteria de Datos (SIVIGILA)



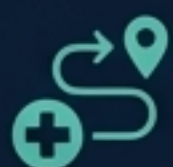
Arquitectura de la Intervención

Nivel Individual (El Paciente)



Notificación inmediata a la EAPB para intervención oportuna.

Activación de la línea nacional de toxicología (en casos de envenenamiento).



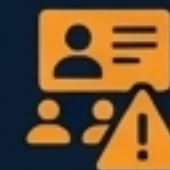
Enrutamiento obligatorio a las RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud).

Nivel Colectivo (El Entorno)

Coordinación ESE, EAPB y Redes de Urgencias.



Educación comunitaria para identificar pródromos.



Creación de Familias Protectoras y redes de apoyo mutuo para manejo de crisis.

Enrutamiento RIAS: Abordaje Integral



Promoción y Mantenimiento
Detección temprana de depresión a lo largo del ciclo vital.



Materno-Perinatal
Atención a depresión post-parto.

**Paciente
(Ficha 356)**



Trastornos Mentales
Rehabilitación integral para población general.



Violencias
Atención a síntomas derivados de exposición a abusos y violencia.



Consumo de SPA
Canalización para abuso de sustancias psicoactivas.

Síntesis: El Circuito de Prevención



**El ciclo se rompe.
La vida se preserva.**